SUJECIÓN FÍSICA

Redactado por:	Aprobado por:
Grupo de SUJECIÓN FÍSICA 4H *Fecha noviembre de 2021*	*Dirección Médica HUFJD* *Dirección de Enfermería HUFJD* *Dirección Médica HUGV* *Dirección de Enfermería HUGV* *Dirección Médica HUIE* *Dirección de Enfermería HUIE* *Dirección Médica HURJC* *Dirección de Enfermería HURJC* *Fecha marzo 2022*

CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO A ULTIMA VERSIÓN		
Versión	Fecha	Modificación
0	Marzo 2022	Versión Inicial partiendo del procedimiento trabajado previamente por el grupo de trabajo 4H PROTOCOLO SUJECIÓN FÍSICA. Incorporación de comentarios e inclusión de circuito para la prescripción.

SUJECIÓN FÍSICA
4H-11-P1
V.0

AUTORES: Grupo de trabajo Sujeción física 4H

- Santiago Ovejero, facultativo de psiquiatría (HUFJD)
- Olga Martín, supervisora dirección de enfermería (HUFJD)
- Sandra Seco, enfermera de psiquiatría (HUFJD)
- Irene Aguilar, supervisora de psiquiatría (HUFJD)
- Joaquín García, facultativo de urgencias (HUFJD)
- Mónica Cigüenza, supervisora de urgencias (HUFJD)
- Nuria el Kadaoui, facultativo medicina interna (HUGV)
- Rebeca Muñoz, subdirectora de enfermería (HUGV)
- Ezequiel Di Stasio, jefe de servicio de psiquiatría (HUGV)
- Mª Teresa Cerdan, facultativo de urgencias (HUGV)
- Leopoldo Bárcena, facultativo de geriatría (HUIE)
- María Herrera, facultativo de geriatría (HUIE)
- Ana Belén de Frutos, supervisora de hospitalización (HURJC)
- Marta Ruiz, supervisora de psiquiatría (HURJC)
- Marta González, directora de calidad (HURJC)
- Elvira González, enfermera de sistemas de la información (4H)
- Jose Azofra, consultor médico sistemas de la información (4H)
- Sara Anero, técnico de calidad (4H)
- Patricia Palomera, técnico de calidad (4H)

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE 4
2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 4
3. DEFINICIONES 6
4. DESARROLLO 6
4.1. GENERALIDADES 6
4.2. RESPONSABILIDADES 7
4.3. INDICACIONES 7
4.4. CONTRAINDICACIONES 10
4.5. EVALUACIÓN Y PLAN DE ATENCIÓN 11
4.6. PRESCRIPCIÓN 11
4.7. INFORMACIÓN AL PACIENTE Y SU FAMILIA 12
4.8. ABORDAJE SECUENCIAL 13
4.9. PRECEPTOS LEGALES DE APLICACIÓN 18
4.10. PUNTOS A REFORZAR 19
4.11. COMUNICACIÓN DE COMPLICACIONES ASOCIADAS 19
4.12. EVALUACIÓN 19
5. REGISTROS Y ANEXOS 20

1. OBJETO Y ALCANCE

La sujeción física o mecánica es un último recurso terapéutico que se utiliza en situaciones extremas para controlar conductas que suponen alto riesgo para el propio paciente, como para otros pacientes y profesionales sanitarios, después de que hayan fracasado el resto de las medidas alternativas, como el abordaje o contención verbal, las medidas ambientales y/o de conducta y la contención farmacológica.

La sujeción de un paciente implica la restricción de un derecho fundamental de la persona (la libertad) y una cualidad inherente al ser humano (la dignidad). Restringir esta libertad solo se entendería cuando el beneficio para el paciente superase ampliamente el perjuicio que esta limitación pudiera causar. Por tanto, la aplicación de sujeciones físicas debe respetar la intimidad, confidencialidad y vulnerabilidad del paciente.

En base a la evidencia científica existente, las sujeciones físicas se pueden considerar procedimientos que pueden suponer riesgos en la seguridad del paciente. Procurar la mayor seguridad en estas situaciones es un objetivo fundamental e implica practicar una atención a la salud libre de daños evitables, aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren y mitigar sus consecuencias, procurando un ambiente sin riesgos, tranquilo y terapéutico.

El objeto de este protocolo es promover la tolerancia cero con el abuso de sujeciones, así como favorecer la adopción de especiales precauciones ante personas en situaciones de fragilidad, dependencia y vulnerabilidad. Para su elaboración se han seguido las recomendaciones para la elaboración de protocolos en caso de aplicación de sujeciones físicas, según lo establecido en la resolución 106/17 del viceconsejero de sanidad y director general del servicio madrileño de salud, sobre instrucciones relativas al uso de sujeciones físicas y químicas en centros hospitalarios del servicio madrileño de salud.

Objetivos:

1. Dotar a los profesionales sanitarios y no sanitarios de los conocimientos y pautas a seguir en el caso que se establezca la necesidad de utilizar sujeción mecánica a pacientes.
2. Garantizar la seguridad de los pacientes, de los familiares y del personal asistencial y mejorar la calidad asistencial.
3. Potenciar la utilización de medidas alternativas a la sujeción mecánica para reducir así su uso.
4. Dar conocer las implicaciones éticas y jurídico-legales que tiene el aplicar la sujeción mecánica en la práctica asistencial para prevenir los riesgos derivados de estas intervenciones.
5. Establecer el registro de datos de utilidad clínica y para la evaluación posterior de la aplicación de sujeción física.

Este protocolo es de aplicación en todas las unidades de hospitalización y unidades especiales del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario General de Villalba, Hospital Universitario Infanta Elena y Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

- Constitución Española: Art. 17.1 “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”
- Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (Art. 8 y 9.2b)

- Ley de enjuiciamiento Civil (Art.763) sobre internamiento no voluntario.
- Resolución 106/2017, de 27 de enero, del Viceconsejero de Sanidad y Director General del Servicio Madrileño de Salud por la que se aprueban las instrucciones relativas al uso de sujeciones físicas y químicas en centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud
- Recomendaciones para la elaboración de protocolos y registros de sujeciones físicas, según lo establecido en la resolución 106/17 del Viceconsejero de sanidad y Director General del Servicio Madrileño de Salud, sobre instrucciones relativas al uso de sujeciones físicas y químicas en Centros Hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud.
- Manual de estándares para hospitales de la Joint Commission International 7ª edición (atención a pacientes, COP 3)
- Instrucciones básicas y recomendaciones para la elaboración y obtención del consentimiento informado. FJD. Mayo 2005
- McClosey et al. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 4ª Edición. Ed. Elsevier Mosby; 2007
- Tideiksaar, R. Caídas en ancianos. Prevención y tratamiento. Ed. Masson; 2005
- Alerta nº 5 de Seguridad en Atención Sanitaria del Centro de Investigación para la Seguridad Clínica de los Pacientes: Precauciones en el uso de la inmovilización física de los pacientes. Disponible en: http://www.fadq.org
- Convenio de Asturias de bioética 1987.
- Comité Interdisciplinar de Sujeciones. Documento de Consenso sobre Sujeciones Mecánicas y Farmacológicas. SEGG.
- Rodríguez Delgado J. Contenciones mecánicas en geriatría: propuestas técnicas y recomendaciones de uso en el ámbito social. RevEspGeriatrGerontol 2013).
- M. Porta, R. Miralles, C. Conil. Registro de caídas del centro geriátrico municipal de Barcelona. Características de las caídas y perfil de los pacientes. Revista española de Geriatría y Gerontología 2001,36: 270.
- Castle NG, Engberg J. (2009). The Health Consequences of Using Physical Restraints in Nursing Homes. Med Care, 47(11), 1164-1173. 14. Alerta de Seguridad
- White S. 1999. Helpful Hints on Preventing Injury Related to Restraints. OAHHS. Disponible en: http://www.oahhs.org/issues/safety/restrainstshints.htm [noviembre, 2004].
- Healey F, Oliver D, Milne A, Connelly J. “The effect of bedrails on falls and injury: a systematic review of clinical s tudies ”. Age ageing. 2008; 37:368378. M. Porta, R. Miralles, C. Conil Registro 4. 5. de caídas del centro geriátrico municipal de Barcelona. Características de las caídas y perfil de los pacientes. Revista española de Geriatría y Gerontología 2001,36: 270.
- Estévez-Guerra et al. The use of physical restraints in long-term care in Spain: a multi-center cross-sectional study. BMC Geriatrics (2017) 17:29
- Huang H, Huang Y, Lin K, Kuo Y. Risk factors associated with physical restraints in residential aged care facilities: a community-based epidemiological survey in Taiwan. J AdvNurs. 2014;70(1):130–43. doi:10.1111/jan.12176

3. DEFINICIONES

Sujeción física o mecánica: Cualquier acción o procedimiento que evita la libertad de movimiento de una persona a la posición que elija y el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo, con cualquier método aplicado sobre ella, o adyacente a ella, del que no puede liberarse con facilidad.

Sujeción química: Aplicación de forma deliberada e intencional de un medicamento para controlar un problema de base no psiquiátrica ni médica, para lo que existe mejor tratamiento y que acaba limitando o restringiendo los movimientos o actividad física y las actividades de la vida diaria del paciente, así como su funcionamiento mental.

Agresividad: conducta que produce daño en el medio ambiente o/y daño físico o psíquico en la persona que origina la conducta o en las personas que están cercanas.

Violencia: es una conducta agresiva dirigida a personas.

Agitación psicomotriz: es un síndrome que puede aparecer en cualquier cuadro psiquiátrico y en múltiples cuadros orgánicos, manifestada por un estado de intranquilidad psíquica y un aumento inmotivado, desproporcionado y desorganizado de la motilidad. Dichos movimientos son con frecuencia improductivos y pueden generar de forma dirigida o no auto-heteroagresión.

4. DESARROLLO

4.1. GENERALIDADES

El abordaje de pacientes que presentan agitación y riesgo de conductas auto o heteroagresiva es una de las técnicas que precisan un mayor control por parte del personal sanitario y no sanitario dado el potencial lesivo y destructor, por lo tanto requiere un aprendizaje y unos conocimientos suficientes para actuar sin agravar la situación potencialmente peligrosa, ya que es algo realizado contra la voluntad del paciente; además, que su modo de hacerlo respete los derechos fundamentales del paciente como persona.

Es preciso recordar que las acciones recogidas en este protocolo son actuaciones sanitarias en un medio sanitario: actos médicos sobre pacientes. En este sentido se considera que la conducta objeto de la sujeción física es un síntoma y por tanto justifica una actuación contra la voluntad del individuo, y adjetiva el acto como médico, y al sujeto como paciente.

Algunos estudios demuestran que las personas sometidas a sujeciones desarrollan consecuencias negativas sobre la esfera psíquica, como aislamiento social, pérdida de la autoestima, trastornos psico-afectivos (ansiedad-depresión), estrés, inquietud, agitación, agresividad y delirium.

Las personas que utilizan sujeciones de forma continuada tienen un alto riesgo de desarrollar rigidez, anquilosis, atrofia y pérdida de la masa muscular, con deterioro funcional y tendencia a la inmovilidad, estreñimiento, incontinencia urinaria y fecal, úlceras por presión, infecciones y dolor.

Otras complicaciones pueden ser la asfixia, especialmente en decúbito prono y la aspiración, en supino (Mohr et al, 2003) NICE Guidelines.

Dado que la sujeción mecánica se trata de una práctica controvertida que genera problemas éticos, clínicos y sociales, para el abordaje de pacientes que presentan agitación o un riesgo para su seguridad o la de otros pacientes o profesionales se hacen imprescindibles:

- una **Valoración exhaustiva** tanto del riesgo-beneficio como de la existencia o no de otras alternativas,
- una **Planificación correcta de los Cuidados** posteriores que se deben realizar ininterrumpidamente por los diferentes turnos de profesionales que atiendan al paciente,

- Cuando sea necesario para una adecuada atención sanitaria aplicar una sujeción durante la hospitalización, se **informará al paciente o a su familia** con carácter previo, siempre que las circunstancias lo permitan.

Señalar, por tanto, que la aplicación de sujeción física está reservada para situaciones excepcionales y extremas, adoptada por riesgo grave e inminente para la persona o para terceros, y ante el fracaso de otras alternativas de sujeción (verbal y/o química), respetando el principio de autonomía y dignidad del paciente en todo momento.

4.2. RESPONSABILIDADES

Todo el personal tanto sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería) como no sanitario (celadores, personal de seguridad) disponible en cada unidad está obligado a prestar su colaboración si ésta es requerida por el responsable de la sujeción mecánica. Los supervisores de enfermería de cada unidad son los responsables de velar por el cumplimiento de este protocolo.

4.2.1. Médico

- La indicación debe figurar por escrito en las órdenes médicas.
- Informa al paciente y a sus familiares de los motivos y objetivos de la medida.
- Decide su finalización tras la valoración conjunta con el resto del equipo.

4.2.2. Enfermera

- Dirige la inmovilización y coordina su ejecución.
- La indica en caso de urgencia y ausencia del médico.
- Es responsable de la inmovilización física.
- Es responsable de los cuidados y controles posteriores.

4.2.3. Técnico auxiliar de enfermería

- Coopera en la ejecución y supresión de la inmovilización física.
- Participa en los cuidados, el control y observación del paciente.
- Se ocupa de la custodia y mantenimiento de los equipos materiales de la inmovilización.

4.2.4. Celador

- Colabora en la instauración de la contención y transporte del paciente.
- Se ocupa de la custodia y mantenimiento de los equipos materiales de la inmovilización.

4.2.5. Personal de seguridad

- Pueden ser requeridos para colaborar en el procedimiento, con su presencia y/o intervención en la inmovilización del paciente si, excepcionalmente, no es suficiente con el personal de la propia unidad.

Esta actuación tiene unas connotaciones éticas y legales muy importantes, por la situación de riesgo y vulnerabilidad en que se encuentra el paciente. Es precisa una especial sensibilización de los profesionales con el procedimiento técnico, la indicación, la información adecuada al paciente y familia y el cuidado de la persona atendida.

4.3. INDICACIONES

La sujeción, está indicada ante situaciones que supongan una amenaza urgente e inmediata para la vida o integridad física del propio paciente.

- Sólo debe realizarse cuando hayan fracasado todas las alternativas posibles.

- Debe usarse siempre la técnica menos restrictiva posible que garantice este objetivo.

- Su indicación será individualizada y limitada en el tiempo, retirándose lo antes posible y con revisiones periódicas de su indicación.

1. **AGITACIÓN MANIFIESTA**: Aumento de la psicomotricidad con pérdida total del autocontrol y consciencia de su estado.

2. **AUTO-HETEROAGRESIVIDAD**: Conducta que implica peligrosidad y destructividad hacia sí mismo o hacia terceros.

   – Riesgo autolesivo

   – Riesgo para la integridad de otros pacientes, familiares y/o personal: insultos, amenazas verbales, amenazas físicas o francas agresiones.

   – Daños materiales

3. **EVITAR ALTERACIONES EN PLAN TERAPEUTICO DEL PACIENTE**

   – riesgo de fuga en paciente no competente

   – riesgo de retirada de dispositivos por el paciente

   – riesgo de caídas

4. **EVITAR ALTERACIONES EN PLAN TERAPEUTICO DE OTROS PACIENTES**

5. **AUSENCIA DE TUTORES LEGALES EN CASO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS**

6. **SOLICITUD VOLUNTARIA DEL PACIENTE**

La indicación de la inmovilización debe quedar reflejada en la historia clínica del paciente y debe incluir al menos los siguientes aspectos:

- Descripción de las conductas del paciente que justifican el uso de la inmovilización.
- Alternativas no restrictivas que se han intentado.
- Respuesta inicial del paciente a la misma y justificación para mantenerla (si ha sido puesta en una situación de urgencia sin intervención del facultativo).

4.3.1. Indicaciones específicas según el tipo de dispositivo autorizado

CINTURÓN	INDICACIONES
	• Uso en pacientes encamados. • Limitación de la movilidad, y prevención de caídas.

MUÑEQUERAS/TOBILLERAS	INDICACIONES
	• Uso en paciente en cama o en silla. • Limitación de la movilidad de miembros superiores. • Para inmovilización de miembros inferiores. No recomendado la inmovilización de MII en paciente geriátricos.

MANOPLAS COMO INMOVILIZACIÓN	INDICACIONES
	• Permite sujetar las manos del paciente a la cama y prevenir autolesiones, agresiones o manipulación del equipo clínico. • Indicado para evitar retirada de dispositivos clínicos.

CONTENCIONES TORÁCICAS	INDICACIONES
	• **Uso exclusivo con el paciente en silla de ruedas**. • Apropiado para pacientes con control mínimo del tronco y que requieren apoyo alrededor del torso y sobre los hombros para mantenerse en posición vertical. Impide inclinarse hacia adelante

PETO TORACO-PÉLVICO EN SILLA DE RUEDAS Y SILLÓN		INDICACIONES
		• Ideal para pacientes que necesitan control postural del tronco. La inmovilización perineal evita que el paciente se desplace hacia abajo. • Uso en butaca

CINTURÓN Y MUÑEQUERAS/INMOVILIZACIÓN DE PIE MECÁNICAS	INDICACIONES
	• Limitación de la movilidad y prevención de caídas. • Limitación de la movilidad de miembros superiores. • Para inmovilización de miembros inferiores.

– **BARANDILLAS:** No son sujeciones físicas en sentido estricto, si bien pueden ser utilizadas con fines restrictivos, o ser restrictivas, aunque no se apliquen con ese fin.
Dado que las personas pueden tener diferentes hábitos de sueño, la creación de un "entorno cama" seguro que tenga en cuenta las necesidades de los pacientes, la comodidad y la libertad de movimiento deben estar basadas en la evaluación individualizada.
En aquellos casos donde la seguridad y confort en la cama estén amenazados, y esté indicado evitar las barandillas, el equipo asistencial busca alternativas válidas a la instauración de estas, que den la seguridad y comodidad necesarias.

4.4. CONTRAINDICACIONES

1. Posibilidad de abordajes alternativos que garantice la seguridad del paciente (por ejemplo, presencia de cuidador continuo...)
2. Orden expresa del médico responsable
3. Que exista negativa expresa por parte de la familia.
4. Que la medida provoque en el paciente una consecuencia mayor que se pretende evitar.
5. Dificultad en prestar supervisión continuada y cuidados complementarios.
6. Conveniencia, comodidad o dejadez de los profesionales o personal cuidador.
7. Material o dispositivos inadecuados, no homologados y que puedan poner en riesgo la seguridad de la persona a la que se aplican.

No se debe usar:

– Como un castigo al paciente por una transgresión.

– Como conveniencia del personal.

– Cuando se desconozca su estado general de salud (salvo riesgo mayor para la salud, en caso de no realizar la IT).

– Cuando exista una terapéutica diferente y de similar eficacia, como por ejemplo la sedación medicamentosa.

– Por último, ningún paciente en situación final de su vida en los que apareciera un cuadro de agitación y delirium, debería fallecer con sujeciones mecánicas; ya que existen medidas farmacológicas y vías de administración de las mismas que permiten que el paciente pueda morir tranquilo, sin sujeciones mecánicas, recurriendo a la sedación paliativa.

4.5. EVALUACIÓN Y PLAN DE ATENCIÓN

Antes de todo sería conveniente realizar una evaluación (inicial y continua) integral de las esferas física, psíquica, funcional y social, deterioro cognitivo o demencia, posibles alteraciones psicológicas y conductuales, buscando factores de riesgo y tratando de corregirlos de una forma precoz.

Las **COMPLICACIONES** de la sujeción física a tener en cuenta en la valoración de riesgos y necesidades son:

a) Heridas: erosiones, laceraciones, desgarros musculares y de los plexos nerviosos.
b) Úlceras cutáneas por presión
c) Estrangulamientos, asfixia, isquemia de los miembros, etc.
d) Riesgo de atrofia muscular, rigidez o anquilosis
e) Incontinencia urinaria y fecal. Estreñimiento
f) Síndrome de inmovilidad
g) Enfermedad tromboembólica venosa.
h) Riesgo de muerte súbita.
i) Aislamiento social y del entorno, la pérdida de la autoestima y de la dignidad, trastornos psicoafectivos, estrés, inquietud, agitación y agresividad.
j) Sujeciones químicas: caídas, deterioro funcional y muerte.

Tras esta valoración se pueden hallar una serie de FACTORES PREDISPONENTES: déficits sensoriales, psicótropos, problemas psíquicos, demencia, delirium, alteraciones de la marcha y equilibrio con riesgo de caídas, etc.

También se pueden detectar una serie de FACTORES DE RIESGO O DESENCADENANTES: fiebre, dolor, disnea, prurito, retención urinaria, estreñimiento e impactación fecal.

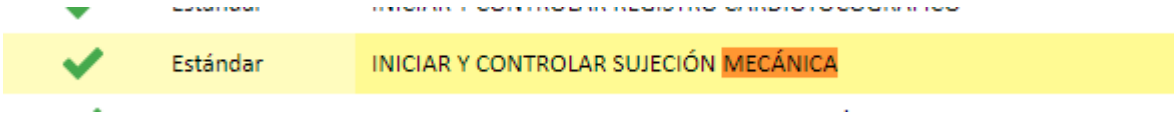
Una correcta evaluación hará posible la realización de un Plan de Atención Individualizado con programas de actuación no farmacológica:

- Sobre la conducta
- Sobre los trastornos del equilibrio y de la marcha
- Corrigiendo las disfunciones neurosensoriales
- Actuando en la misma línea por parte de todos los miembros del equipo

4.6. PRESCRIPCIÓN

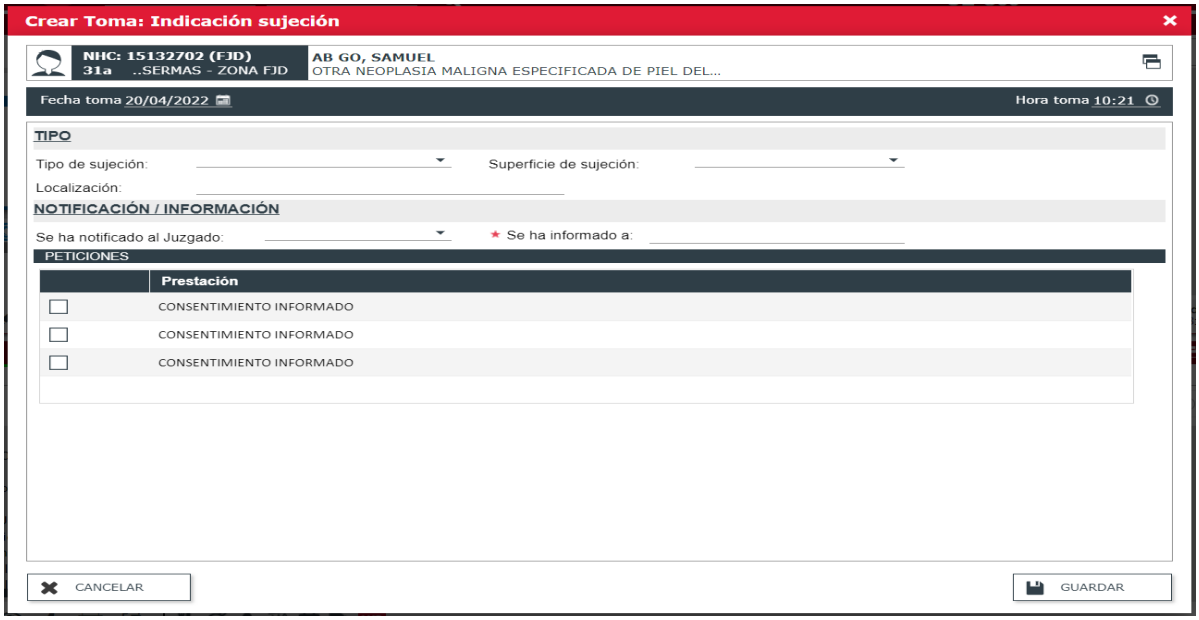
Una vez detectada la necesidad de utilizar la sujeción física, la enfermera avisa al médico responsable para que confirme o no el poner en marcha el protocolo.

La indicación de la sujeción debe figurar en las órdenes médicas en la historia clínica electrónica (Casiopea) utilizando la prescripción no farmacológica **"INICIAR Y CONTROLAR SUJECIÓN MECÁNICA**":



Al prescribir la actividad, se levanta el formulario en el que el médico marca los ítems de indicación (tipo, informado a, entrega de folleto informativo y generar CI) y con el que se realiza la petición (y por tanto, se genera el CI en la historia clínica electrónica).

Debe indicarse en el ítem correspondiente si se realiza notificación al juzgado realizada mediante el formato incluido en el anexo 3.



En **casos de urgencia** la enfermera puede decidir la aplicación de esta medida (siguiendo los criterios de indicación protocolizados) cuando no está el médico presente, debiéndolo registrar y comunicar al médico responsable lo antes posible, así como en los casos en los que valore la conveniencia de su supresión.

4.7. INFORMACIÓN AL PACIENTE Y SU FAMILIA

Siempre que sea posible, se informa verbalmente al paciente y a la familia entregando **hoja informativa** (Anexo 1) dejándolo registrado en Historia Clínica Electrónica en el formulario de indicación médica y en el formulario de enfermería de sujeción física utilizando el campo “entrega del folleto informativo”.

En caso de que la aplicación de la sujeción se realice a una persona que no tiene capacidad para consentir la medida, se informará con carácter previo, siempre que las circunstancias lo permitan, y en todo caso posteriormente, al paciente, al tutor legal y a la persona cuidadora que se encuentre en ese momento, sobre los motivos de su utilización y su carácter temporal; así como se entregará un folleto/hoja informativa (Anexo 1) como apoyo a la información verbal.

El acto de **consentimiento informado** de una persona con capacidad y en condiciones de decidir es necesario que se recoja en la historia clínica electrónica utilizando el documento incluido en el Anexo 2 que deberá ser firmado de forma electrónica por el paciente. **Dicho documento se activa de forma automática con la prescripción electrónica de la sujeción física por parte del médico.**

Cuando el paciente que no sea capaz de tomar decisiones, o su estado físico o cognitivo no le permita hacerse cargo de su situación, es de aplicación en estos casos el consentimiento por representación.

En situaciones especiales, cuando el médico responsable valore que existe riesgo y que se puede recurrir a la aplicación de sujeción física durante su hospitalización, puede realizar el acto de consentimiento informado con carácter preventivo quedando reflejado en historia clínica la justificación. En estos casos, se puede acceder al consentimiento informado incluido en el anexo 2 mediante la petición “CONSENTIMIENTO INFORMADO SUJECIONES”.

4.8. ABORDAJE SECUENCIAL

4.8.1. Abordaje verbal

Ante todo, iniciaremos unas "Medidas verbales" con la finalidad del "enfriar" la situación, disminuyendo la ansiedad, la hostilidad y la agresividad y previniendo posibles ataques violentos; informando del carácter transitorio de la crisis y potenciando su autocontrol. Así intentaremos una actitud tranquila:

- Invitar y conducir a la persona a un área privada y segura para el paciente y el profesional dónde poder hablar, si es posible.
- Escuchar con calma al paciente, permitiéndole expresar sus temores, sus miedos; sin interrumpir su discurso.
- Evitar gestos bruscos y espontáneos.
- Mantener una actitud firme, acogedora, sin evitar el contacto visual, y utilizando un tono de voz calmado y de bajo volumen.
- Empatizar con la persona irritada cuando la hostilidad se haya reducido, sin necesidad de mostrar acuerdo, reservando los propios juicios sobre lo que debería o no hacer.
- Pedir ayuda si se tiene dudas de poder enfrentarse sólo a la situación.

Guía de Desescalado Verbal
PREVIO 1. Lugar adecuado 2. Profesional informado y en disposición óptima.
TOMA DE CONTACTO 3. Respetar el espacio personal: a. Respetar al paciente. b. Respetar el espacio. 4. No ser provocativo, ser pacífico, tranquilizador y amistoso: a. Utilizar adecuadamente el lenguaje corporal. 5. Establecer contacto verbal adecuado: a. Solo una persona interactúa con el paciente. b. Se ofrece información.
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE 6. Utilizar el lenguaje verbal de forma efectiva: a. Ser conciso, hablar claro y simple. b. Repetir el mensaje tantas veces como sea necesario (técnica del disco rayado). 7. Escuchar con atención lo que dice el paciente: a. Escucha activa. b. Ley de Miller [1]. c. Fogging [2] (banco de niebla).
MANEJO DE LA SITUACIÓN 8. Poner los límites, de forma que se cree un ambiente de trabajo adecuado: a. Explicitar los límites. b. Utilizar la confrontación de forma sutil. 9. Ofrecer alternativas: a. Dar margen de elección al paciente.
DEBRIEF[3] 10. Analizar el episodio: a. Realizar un análisis con el paciente. b. Realizar un análisis con el equipo.

[1] **Ley de MILLER:** La ley de Miller dice: "para comprender lo que otra persona está diciendo, debes asumir que lo que dice es verdad y tratar de imaginar qué de lo que dice podría ser verdad", se debe suspender el juicio sobre lo que está diciendo, así podremos comprenderlo inicialmente sin que nuestras interpretaciones personales influyan en el mensaje.
[2] **Fogging (banco de niebla, empañado):** Es una conducta empática en la que se trata de encontrar algo en la posición del paciente con lo que se podría estar de acuerdo.
[3] **Debrief:** Recapitulación del episodio (por un lado con el paciente y, por otro, con los miembros del equipo implicados) para recoger, de forma analítica, información sobre la experiencia vivida.

Si no es posible esta conversación por la agresividad del paciente o por la situación clínica, el médico siempre debe informar al paciente sobre las medidas a utilizar para evitar su daño y el de los demás o para conseguir aplicar el tratamiento que sea necesario. Informaremos así mismo a la familia tal y como se describe en el apartado INFORMACIÓN AL PACIENTE Y SU FAMILIA.

En caso de ser necesario, finalmente, se iniciará el protocolo de sujeción tanto física como química.

4.8.2. Medidas ambientales y/o conductuales

- Cambiar de entorno social: introducir figuras de autoridad, retirar personas provocadoras, querulantes o que confronten al paciente.
- Restricción de estímulos: eliminar y/o reducir el número de estímulos
- Posibilitar y canalizar la manifestación de malestar, demandas, desacuerdos…

4.8.3. Preparación

- Evitar en lo posible toda expectación y ubicar al paciente en habitación individual o es su defecto sin otros pacientes, siempre que sea posible.
- Procurar crear un ambiente confortable en la habitación. A ser posible un paciente con sujeción deberá estar en una habitación lo más cercana posible al control de enfermería.
- El personal que vaya a intervenir en la sujeciónno debe llevar objetos que puedan producir daño o romperse.
- Solicitar un conjunto de sujeción. No usar vendas o gasas como inmovilizaciones por el riesgo de lesiones vasculares y neurológicas.

4.8.4. Acción

El objetivo de la sujeción mecánica es la limitación de movimientos de parte o de todo el cuerpo del paciente, a fin de prevenir lesiones en el propio paciente o a otras personas, en los casos en los que hayan fallado otras alternativas como la contención verbal o la contención química, o bien como coadyuvante de ambas.

A. Consideraciones previas:

Valorar la situación en la que un paciente pueda perder el control y adoptar conductas físicamente peligrosas, para sí mismo o para los demás. Elobjetivo es evitar el daño inminente y lograr la seguridad de todos los pacientes, se avisa al médico responsable para que confirme o no el poner en marcha el protocolo y se llama al número de profesionales necesario, debiendo actuar de forma rápida y coordinada.

Se designa al personal encargado de dirigir la inmovilización. Normalmente esta función está a cargo de la enfermera y/o médico responsable del paciente.

Siempre que sea posible, informar verbalmente al paciente y a la familia entregando hoja informativa (Anexo 1) según se indica en el apartado de **INFORMACIÓN AL PACIENTE Y SU FAMILIA**.

Tras la información de las medidas terapéuticas que vamos a tomar, se da el tiempo necesario para que acepte y colabore, en caso contrario se procederá a reducirle.

Evitar intervenir hasta que se disponga del suficiente personal. Para casos de agitación grave se recomienda un mínimo de 5personas, una persona para cada miembro y otra para la cabeza. Es necesario tener en cuenta que la sola presencia del grupo puede ser disuasoria para el paciente.

Si otros pacientes han presenciado el episodio de la inmovilización, es necesario hablar con ellos después de la crisis, permitiéndoles que expresen sus sentimientos al respecto y que entiendan la pertinencia de las medidas adoptadas.

B. Precauciones:

Las personas que vayan a entrar en contacto físico con el paciente adoptarán las medidas de precaución universales.

- Preparar la cama, asegurándose de que esté frenada y se colocará la sujeción de cintura previamente en la misma.
- Eliminar del alcance del paciente cualquier objeto potencialmente peligroso.
- Retirar objetos de la ropa del paciente que pudieran dañarle.
- El personal que vaya a intervenir en la inmovilización no llevará objetos que puedan producir daño o romperse (gafas, reloj, anillos, cadenas, bolígrafos, etc.).
- Inclinación de la cama a 45 grados salvo contraindicación médica.

C. Ejecución:

El profesional designado encargado de la inmovilización mantendrá la comunicación verbal con el paciente, debiendo dar tiempo al paciente para aceptar las demandas verbales, para que colabore y se tumbe en la cama.

Si no accediese a ello y el paciente se muestra poco colaborador, agresivo o negativo, sin lugar a la discusión verbal se procederá a reducirle, trasladarle y tumbarle en la cama.

C.1 Reducción:

Debe llevarse a cabo encargándose una persona de cada extremidad preestablecida y otra de la cabeza. Se realizará preferentemente cuando el paciente esté distraído. Deberá girarse de espaldas sobre el suelo y se sujetará a nivel de los hombros, antebrazos y por encima de las rodillas y tobillos. Un quinto miembro controlará la cabeza de manera que no pueda golpearse o pueda golpear a algún miembro del equipo. Evitar, en lo posible, hablar con el paciente mientras se realice la sujeción, y si es necesario, que sea una única persona la que se dirija al paciente, y todo ello con el fin de evitar que puedan surgir comentarios críticos o provocativos hacia paciente.

C.2 Traslado:

Para trasladar al paciente que no colabore y esté agitado y/o violento se realizará sujetándolo por las piernas, a la altura de las rodillas, y por los brazos, alrededor de los codos con apoyo bajo los hombros. No deben forzarse las articulaciones más allá de los límites fisiológicos.

C.3. Tumbarle en una cama

Se colocará al paciente en decúbito supino en la cama (excepto en pacientes intoxicados o con disminución de conciencia que se dejarán en posición de seguridad) y se procede a la sujeción completa o parcial indicada. La sujeción se realizará por este orden: Cintura, miembros inferiores y miembros superiores.

Si la sujeción se realiza en sillón se adoptarán las medidas preventivas necesarias y se informará tanto al paciente, familiar y/o cuidador de las precauciones a tener en cuenta.

Si el paciente presenta alto riesgo de caídas no se levantará al sillón si no va a poder estar acompañado y vigilado por un familiar y/o cuidador o por personal de la unidad.

C.4. Modo de aplicación de los dispositivos de sujeción:

Grado de sujeción física: Siempre se debe utilizar una sujeción lo menos restrictiva posible.

No se debe inmovilizar un único miembro por el riesgo de lesiones (dislocación de hombros, erosiones...)

La mínima: Tronco+1 extremidad (según las condiciones del paciente).

La máxima: Tronco +4 extremidades +tirantes pectorales

No se colocar nunca sujeciones en las 4 extremidades ni en ninguna de las extremidades inferiores en el paciente geriátrico o anciano frágil, salvo indicación facultativa expresa y por motivos excepcionales.

En casos de episodio de agitación psicomotriz grave se seguirá el circuito establecido en cada hospital.

Sujeción abdominal:

- Cama: paciente semiincorporado.
- Silla: paciente con la espalda apoyada en el respaldo.
- Colocar cinturón alrededor de la cintura del paciente.
- Cruzar las cintas por detrás.
- Anudar las cintas a ambos lados del bastidor de la cama. Nunca a las barandillas.
- El paciente podrá girar a cada lado 90 grados sin peligro de caída.
- Si se desea mayor sujeción volver a pasar de nuevo las cintas a través de las anillas laterales y átelas al bastidor.
- Se comprobará y revisará cada uno de los puntos de sujeción para evitar daños en la piel o problemas por compresión excesiva.
- Mantener la cabeza del paciente ligeramente levantado para prevenir posible aspiración pulmonar y disminuir sus sentimientos de indefensión.
- Si se sujeta el tronco con un cinturón a la cama se deberá tener especial precaución de su correcta colocación para evitar excesiva compresión o deslizamientos que puedan ocasionar lesiones (dificultarle la respiración, estrangulación...).
- Comprobar que el personal sanitario pueda manipular fácilmente los accesos venosos, drenajes o sondas.
- El paciente, una vez sujeto, queda en situación de indefensión, por lo que hay explicarle que todas sus necesidades serán atendidas y se realizarán visitas periódicas por parte del personal.

Extremidades con imán o velcro:

- Ajustar y fijar la muñequera/ sujeción pie con el cierre de velcro o imán.
- Tensar y anudar las cintas a ambos lados del marco de la cama. **Nunca a las barandillas.**
- La sujeción debe permitir la perfusión endovenosa y cierta movilidad de las extremidades.

D. Cuidados durante la sujeción:

La sujeción del paciente implica incrementar la atención y vigilancia del paciente por parte de los profesionales responsables.

D.1 Médico responsable y/o de guardia:

Valorar al enfermo tras la sujeción de forma continuada con el fin de asegurar que se identifican sus necesidades de atención.

Dejar registrado en la historia clínica del paciente tanto la indicación de la sujeción, su continuidad y las pautas a seguir (Incluido el uso de barandillas).

D.2 Enfermera responsable:

Valoración continuada mientras persista la sujeción a fin de resolver cualquier contingencia que pudiera surgir, siendo necesario:

- Controlar periódicamente mediante su presencia física a cualquier paciente bajo sujeciones, revisando en cada ocasión el estado general del paciente, el estado de las sujeciones y cualquier otra necesidad que pudiera surgir y comunicando las incidencias observadas durante cada visita.

- Realizar visitas de control periódicas por el personal de enfermería, con mayor frecuencia si el estado clínico del paciente así lo requiere, valorando y registrando las posibles anomalías detectadas para comunicarlas al facultativo responsable e iniciar los cuidados específicos que se requieran.

Durante todo el tiempo que dure sujeción será necesario controlar y vigilar:

- Estado general del paciente.
- Constantes vitales por turno.
- Zonas de sujeción: vascular, nerviosa y particular, las lesiones por fricción, etc…
- Presencia de signos de inflamación e integridad de la piel.
- Estado del paciente: agitación, agresividad y ansiedad.
- Complicaciones de la sujeción física: tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, broncoaspiraciones, asfixia, lesiones, ...
- Permitir perfusión intravenosa adecuada, siempre que se requiera.
- Movilidad posible para el paciente.
- Necesidad de continuar con la sujeción.

Una vez sujeto, si el paciente sigue forcejeando, hay que consultar al facultativo responsable para la valoración de medidas adicionales.

Se deben de efectuar cambios posturales y rotación de la posición de los dispositivos de sujeción periódicamente.

Si la situación clínica lo permite, se debe limitar el tiempo de permanencia en la cama solo para dormir.

La valoración de riesgos, constantes vitales y cuidados proporcionados deben quedar registrados en la historia clínica utilizando los distintos formularios habilitados para ello (valoración de enfermería, enf. sujeción física y plan de trabajo).

E. Supresión de la sujeción física.

- Para la finalización del episodio restrictivo se requiere una valoración conjunta del médico y la enfermera responsable del paciente, cuando la necesidad de tal medida haya finalizado.
- Se debe hacer siempre de forma progresiva a medida que aumente el autocontrol. Lo habitual es proceder a una supresión gradual en presencial de personal clínico, valorando el comportamiento del paciente y explicando en todo momento el procedimiento al paciente y a la familia.
- Procurar que la sujeción física dure el menor tiempo posible.
- Dejar constancia en la historia clínica del paciente todo el proceso asociado a la sujeción.

4.9. PRECEPTOS LEGALES DE APLICACIÓN

- Constitución: Art. 17.1 “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”.
- Ley 41/2002 reguladora de la Autonomía del Paciente. Arts.5, 8.

- Ley de Enjuiciamiento Civil (Art.763)
- Al aplicar una sujeción física completa debe considerarse que el ingreso deja de ser voluntario y por tanto hay que cursar notificación al juez según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil (Art.763)

4.10. PUNTOS A REFORZAR

- Evitar la sujeción mecánica, valorando el riesgo existente e interviniendo precozmente con medidas menos restrictivas.
- La inmovilización física debería utilizarse solamente como último recurso, y sólo cuando los beneficios potenciales sean mayores que el daño potencial.
- Estimular la formación y entrenamiento del personal sanitario en alternativas que eviten el uso de las inmovilizaciones y en las pautas a seguir en el caso de tener que utilizar la inmovilización de pacientes.
- La formación sobre inmovilización física puede reducir con seguridad su uso.
- Sólo utilizar las restricciones de movimiento como medida terapéutica y durante cortos períodos de tiempo.
- Si debe usarse inmovilización física, se recomienda que solamente se emplee el nivel mínimo que garantice la seguridad del paciente, o que facilite el tratamiento.
- Evaluar continuamente a los pacientes con inmovilización física, valorando la posibilidad de retirarla cuanto ésta ya no sea necesaria.
- La intervención debe quedar siempre registrada.
- Mantener el material de inmovilización localizado y en perfectas condiciones para su uso. Comprobar el material cuando se recibe de lavandería, revisando botones, anclajes, velcros...

Lo que nunca se debe hacer es:

- Avergonzar al paciente por su actitud.
- Utilizar estrategias como: Decirle que se calme, ofrecerle medicación “para estar más tranquilo”, negarse a escucharle, elevar el volumen de la voz, mantener una discusión en público o empeñarse en seguir hablando, aunque se esté en vía muerta.
- Nunca sujetar a un paciente agitado en una silla de ruedas o en un sillón por el elevado riesgo de caída.
- **Nunca se utilizará la restricción física como sustituto de vigilancia**

4.11. COMUNICACIÓN DE COMPLICACIONES ASOCIADAS

Cualquier complicación que pudiera estar asociada al uso de la sujeción deberá quedar registrado en la historia clínica y se comunicará al Jefe de Servicio quien deberá de trasladarlo a la Dirección del Hospital. En cualquier caso, se notificará en la plataforma de incidentes de seguridad para su análisis por el comité de seguridad del paciente.

4.12. EVALUACIÓN

La evaluación de este protocolo se realizará dentro del contrato de Gestión de Calidad a través de los registros y notificación de incidentes y será evaluado por el supervisor de Calidad.

Para ello, se medirán anualmente los indicadores que se describen a continuación.

El control del cumplimiento del protocolo estará a cargo del supervisor de cada Unidad.

Indicador de proceso: Uso de medidas de inmovilización terapéutica

Definición: Porcentaje de pacientes con medidas de movilización terapéutica

Objetivo: Disminuir el número de pacientes con sujeción mecánica

Numerador: Número total de pacientes con medidas de inmovilización

Denominador: Número total de pacientes ingresados

Indicadores:

1. N.º de registro de sujeciones físicas realizadas*100/ total de pacientes con sujeciones
2. N.º de pacientes con sujeciones físicas aplicadas*100/ total pacientes ingresados
3. N.º de Hojas informativas entregadas a pacientes (de acuerdo con el modelo propuesto por la Viceconsejería de Humanización de la Asistencia Sanitaria) *100/total de pacientes con sujeciones físicas.
4. N.º de Hojas informativas entregadas a familiares o representantes legales (de acuerdo con el modelo propuesto por la Viceconsejería de Humanización de la Asistencia Sanitaria) *100/total pacientes con sujeciones físicas.
5. N.º de incidencias relacionadas con la aplicación de la sujeción (de acuerdo a las recomendaciones dictadas por la Viceconsejeria de Humanización de la Asistencia Sanitaria) *100/ total de pacientes con sujeciones físicas.
6. N.º de Notificaciones a la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sanitarios/Comisión de Seguridad, de aquellos incidentes en pacientes con sujeción que hubieran producido resultados adversos (daño al paciente) o podrían haberlo hecho (incidentes sin daño), de acuerdo a las recomendaciones dictadas por la Viceconsejeria de Humanización de la Asistencia Sanitaria

5. REGISTROS Y ANEXOS

Anexo 1: Información dirigida a pacientes, familiares o representantes legales.
Anexo 2: Consentimiento informado sujeción mecánica
Anexo 3: Hoja de Notificación al juzgado

HOJA INFORMATIVA DE SUJECIONES FÍSICAS A PACIENTES, FAMILIARES O REPRESENTANTES LEGALES

4H-11-P1- ANEXO 1 V.0

Fundación Jiménez Díaz · Hospital Universitario Rey Juan Carlos · Hospital Universitario Infanta Elena · Hospital Universitario General de Villalba

APLICACIÓN DE SUJECIONES FÍSICAS
INFORMACIÓN DIRIGIDA A PACIENTES, FAMILIARES O REPRESENTANTES LEGALES

Esta hoja informativa se le entrega como complemento a la información verbal que ha recibido como paciente o en calidad de familiar o representante legal, por parte del equipo asistencial de este hospital, según establece la Resolución 106/17 del Viceconsejero de Sanidad y Director General del Servicio Madrileño de Salud por la que se aprueban las Instrucciones relativas al uso de Sujeciones Físicas y Químicas en centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud.

La aplicación de Sujeciones Físicas se reserva exclusivamente para situaciones excepcionales en las que se puede ver amenazada la integridad del paciente o de otras personas.

El equipo asistencial ha tenido en cuenta la situación del paciente antes de tomar la decisión de establecer, como medida extraordinaria, la indicación de aplicar una sujeción física que le proporcione una mayor seguridad.

La Sujeción FÍSICA aplicada será la menos restrictiva y se mantendrá durante el menor tiempo que sea posible. En cualquier caso, el equipo de enfermeras que le atiende irá valorando periódicamente la necesidad de continuar con la sujeción para evitar las complicaciones o efectos adversos que pueden derivarse de su uso.

El uso prolongado de sujeciones físicas es contraproducente, especialmente en personas en situación de mayor fragilidad, dependencia y vulnerabilidad (entre otras, personas mayores, con discapacidad intelectual o con enfermedad mental). Por ello se limitan a una situación concreta del paciente durante el presente ingreso en el hospital, pero nunca fuera de esta circunstancia específica ni una vez producida el alta hospitalaria.

La aplicación de una Sujeción Física no conlleva disminución alguna de los cuidados que el paciente necesite. El plan de cuidados se establecerá tratando de prevenir y disminuir los potenciales efectos negativos de la sujeción física.

No dude en preguntar cualquier aclaración sobre la aplicación de Sujeciones Físicas a los profesionales, solicitando la información en la unidad de hospitalización o consultando al Comité de Ética Asistencial del hospital a través del Servicio de Información y Atención al Paciente.

Si usted desea obtener más información sobre los límites establecidos para el uso de sujeciones, puede consultar la Resolución 106/17 del Viceconsejero de Sanidad y Director General del Servicio Madrileño de Salud por la que se aprueban las Instrucciones relativas al uso de Sujeciones Físicas y Químicas en centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud, en:

http://www.madrid.org/es/transparencia/normativa/resolucion-1062017-27-enero-del-viceconsejero-sanidad-y-director-general-del-servicio

Los profesionales de la salud concebimos la humanización como una característica inherente a la atención sanitaria, con total consideración y respeto a la dignidad, integridad y libertad de la persona

Documento con Dictamen FAVORABLE de fecha de 1 de febrero 2018, emitido por la Comisión Técnica de Coordinación de la Información de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

CONSENTIMIENTO INFORMADO SUJECIÓN MECÁNICA

Este documento intenta explicarle las cuestiones relativas a la utilización de las medidas de sujeción física que se llevarían a cabo a su persona y/o familiar. Léalo atentamente y consulte con el/la profesional facultativo todas las dudas que se le planteen.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Se entiende por sujeción física el uso de maniobras físicas o mecánicas dirigidas a limitar los movimientos de parte o de todo el cuerpo de un paciente, con el fin de protegerlo de las lesiones que pudiera ocasionarse a sí mismo o a otros.
Sus indicaciones son:

- AGITACION MANIFIESTA: Aumento de la psicomotricidad con pérdida total del autocontrol y consciencia de su estado.
- AUTO-HETEROAGRESIVIDAD: Conducta que implica peligrosidad y destructividad hacia sí mismo o hacia terceros.
- EVITAR ALTERACIONES EN PLAN TERAPEUTICO DEL PACIENTE (por ejemplo, riesgo de fuga en paciente no competente)
- EVITAR ALTERACIONES EN PLAN TERAPEUTICO DE OTROS PACIENTES
- SOLICITUD DEL PACIENTE

2. ALTERNATIVAS

El personal médico y auxiliar podrán llevar a cabo estas medidas alternativas antes de iniciar una maniobra de sujeción física.
Abordaje verbal:

- Invitar y conducir a la persona a un área privada dónde poder hablar, si es posible.
- Escuchar atentamente dejando que exprese la irritación antes de responderle y sin intentar calmarle.
- Mantener una actitud firme, acogedora, sin evitar el contacto visual, y utilizando un tono de voz calmado y de bajo volumen.
- Empatizar con la persona irritada cuando la hostilidad se haya reducido, sin necesidad de mostrar acuerdo, reservando los propios juicios sobre lo que debería o no hacer.
- Medidas ambientales y / o conductuales
- Restricción de estímulos: eliminar y/o reducir el número de estímulos ambientales.
- Cambiar de entorno social: introducir figuras de autoridad, retirar personas provocadoras, querulantes o que confronten al paciente.
- Posibilitar y canalizar la manifestación de malestar, demandas, desacuerdos.
- Manejo psicofarmacológico de la agitación
- Serán valorados según la existencia de patología orgánica.

3. CONTRAINDICACIONES

- Posibilidad de abordajes alternativos.
- Cuando se desconozca su estado general de salud (salvo riesgo mayor para la salud, en caso de no realizar la sujeción física).
- Cuando exista una terapéutica diferente y de similar eficacia, como por ejemplo la sedación medicamentosa

4. BENEFICIOS Y RIESGOS

Las medidas de sujeción física son indicaciones médicas en el abordaje de pacientes que presentan agitación y riesgo de conductas auto-heteroagresiva y pueden disminuir el potencial lesivo y destructor de estas conductas.

Debido a la propia naturaleza de la intervención de sujeción física, se requiere vigilar por parte de enfermería:

- Estado de la piel en las zonas de sujeción
- Necesidades de alimentación e hidratación
- Vigilancia de respiración (comprobar la permeabilidad de la vía aérea)
- Constantes vitales, acorde con la gravedad del paciente
- Postural, y la repercusión que la misma pueda tener en su patología
- Escaras y/o edemas. Realizar cambios posturales cuando precise
- Evolución del paciente con respecto al criterio que indicó la sujeción

RIESGOS RELACIONADOS CON LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PROFESIONALES DEL PACIENTE:
Riesgos personalizados, que se derivan de las condiciones peculiares de la (s) patología (s) o estado físico del paciente, así como de las circunstancias personales (creencias, valores, edad) o profesionales relevantes.

Indicar "No presenta riesgos personalizados" en caso de no existir

5. CONSECUENCIAS DE LA NO REALIZACIÓN

Las consecuencias de no realizar una sujeción mecánica serán las derivadas de las indicaciones particulares por las que se ha indicado la misma (evitación de daño a uno mismo, a terceros, administración de tratamiento o cuidados…).

6. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Si, en el caso de decidir consentir la sujeción física inicialmente, en algún momento de la intervención usted desea dejar de consentir, tendría que comunicarlo, poniéndose en contacto con la persona que le informó respecto del consentimiento.

7. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

PACIENTE

D./Dª …… con DNI …….

Declaro que el/la médico, Dr/Dra. ……., me ha explicado de forma satisfactoria qué es, cómo se realiza y para qué sirve esta exploración/ intervención/tratamiento.

También me ha explicado los riesgos existentes, las posibles molestias o complicaciones, que éste es el procedimiento más adecuado para mi situación clínica actual, y las consecuencias previsibles de su no realización.

He comprendido perfectamente todo lo anterior, he podido aclarar las dudas planteadas, y doy mi consentimiento para que me realicen dicha exploración/ intervención. He recibido copia del presente documento.

Sé que puedo retirar este consentimiento cuando lo desee.

En ……a …….. de ……. De 20…..

Firmado….el/la paciente

REPRESENTATE LEGAL

D./Dª …… Con DNI…… y con domicilio en …….. Calle ……, me ha explicado de forma satisfactoria qué es, cómo se realiza y para qué sirve esta exploración / intervención / tratamiento.

También me ha explicado los riesgos existentes, las posibles molestias o complicaciones, que éste es el procedimiento más adecuado para la situación clínica actual del paciente y las consecuencias previsibles de su no realización.

He comprendido perfectamente todo lo anterior, he podido aclarar las dudas planteadas y **doy mi consentimiento** para que se realicen al paciente D./ Dª …… con DNI ……, dicha exploración/intervención/tratamiento. He recibido copia del presente documento.

En …….. a ……. de ……De 20…….

Firmado….el/la representante

MEDICO

Dr./Dra……
. He informado a este/a paciente, y/o a su representante legal, del propósito y naturaleza del procedimiento descrito, de sus posibles riesgos, de las alternativas disponibles, y de las consecuencias previsibles en caso de no realización, dejando constancia de ello en le historia clínica. Asimismo, se le preguntó sobre posibles alergias, la existencia de otras enfermedades o cualquier otra circunstancia patológica personal que pudiera afectar condicionar la realización de este procedimiento/acto asistencial. Se incorpora ese documento a la historia clínica del paciente.

En …….. a ……. de ……De 20…….

Firma

Nº de colegiado ……..

REVOCACIÓN

D./Dª …… con DNI ……

D./Dª …… con DNI …… en calidad de Representante legal, familiar o allegadode [Nombre y dos apellidos del paciente]

REVOCO el consentimiento prestado en fecha [fecha de firma del consentimiento], y no deseo proseguir el tratamiento, que doy con esta fecha por finalizado.

En …… a …… de …… De 20……

Firma del Médico Firma del paciente Firma del representante

N.º Colegiado: ……..

HOJA DE NOTIFICACIÓN AL JUZGADO

4H-11-P1- ANEXO 3
V.0

Fundación Jiménez Díaz · Hospital Universitario Rey Juan Carlos · Hospital Universitario Infanta Elena · Hospital Universitario General de Villalba

HOSPITAL:

SERVICIO:

N.º HISTORIA: _____

ALDECANATO

SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE INTERNAMIENTO URGENTE

Por medio de la presente se comunica que se ha procedido al internamiento del paciente D. _____ en el **Servicio de_____,** por razones de urgencia que han hecho necesaria la adopción inmediata de dicha medida.

Hecho que ponemos en su conocimiento dentro del plazo legal de 24 horas estipulado por el Artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida.

Colegiado nº: _____Madrid, _____